

# F5 인계 요약 보고서 — VP-004

## 핵심 요약

- 환자: 최하은 (VP-004) — 10회차 (2027-01-14), 총 10세션 · 183일
- 주호소: 약을 두 번이나 바꿨는데도 증상이 오히려 더 나빠진 것 같고, 숨 쉬는 것조차 힘들며, 밤이 되면 가슴이 쿵쥔거리고 숨이 안 쉬어지는 공포가 지… (상세 부록 1 참조)
- 위험 플래그: 자살사고 문항(9번) 양성 10회 확인 (1회차, 2회차, 3회차, 4회차, 5회차, 6회차, 7회차, 8회차, 9회차, 10회차) — 임상 확인 권장
- 최신 설문: PHQ-9 26/27 (중증) → (26→26, 1회차 대비)
- 주요 우려: 설문 위험 신호와 CTRS 불일치 9회 — 임상 확인 권장

## 면책 조항

- 자가보고(AI 대화형 문진) 기반 비공식 문서이며 공식 의무기록·의학적 진단이 아닙니다.
- AI 예상질환(하단)은 유사도 기반 참고 정보일 뿐 확률·가능성·진단이 아닙니다.
- 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

## 위험/안전 평가

당해 세션(10회차, 2027-01-14) 위험평가: 자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "아니요, 그런 건... 그냥 이 상태가 너무 무거워서. 숨 쉬는 것조차 힘들어요. 약을 바꿔도... 이게 나아질 수 있는 건가요? 번역..." (상세 부록 2 참조). 위기 단계(CTRS) 3/5 — 급성 우려. 과거 9회 세션에서 설문 자살사고 문항(9번) 양성/안전 의뢰 신호가 동일 세션 CTRS 상승에 반영되지 않아 불일치가 확인됩니다 — 임상 확인이 권장됩니다.

AI가 진행한 대화형 문진 결과이며, 검증된 임상 설문 시행이 아닙니다.

| 세션 | 일자         | 점수    | 9번 문항 | 판정       |
|----|------------|-------|-------|----------|
| 1  | 2026-07-15 | 26/27 | 양성    | 불일치      |
| 2  | 2026-07-22 | 26/27 | 양성    | 불일치      |
| 3  | 2026-07-29 | 26/27 | 양성    | 불일치      |
| 4  | 2026-08-05 | 26/27 | 양성    | 불일치      |
| 5  | 2026-08-19 | 26/27 | 양성    | 불일치      |
| 6  | 2026-09-02 | 27/27 | 양성    | 불일치 · 만점 |
| 7  | 2026-09-16 | 26/27 | 양성    | 일치       |
| 8  | 2026-10-14 | 27/27 | 양성    | 불일치 · 만점 |
| 9  | 2026-11-29 | 26/27 | 양성    | 불일치      |
| 10 | 2027-01-14 | 26/27 | 양성    | 불일치      |

[6회차, 27/27] 동일 척도가 전 세션에서 체계적으로 과대추정(over-endorsement, ISS-F2V-028)되었을 가능성은 이 결과에서 별도로 보정되지 않습니다.

[8회차, 27/27] 동일 척도가 전 세션에서 체계적으로 과대추정(over-endorsement, ISS-F2V-028)되었을 가능성은 이 결과에서 별도로 보정되지 않습니다.

최신 시행 척도 안내: 당해 세션에 F3 문진이 시행되어 별도 최신성 안내가 필요하지 않습니다.

## 주호소 및 현병력

주호소: 약을 두 번이나 바꿨는데도 증상이 오히려 더 나빠진 것 같고, 숨 쉬는 것조차 힘들며, 밤이 되면 가슴이 쿵쥔거리고 숨이 안 쉬어지는 공포가 지속됨

현병력: 약을 두 번이나 바꿨는데도 오히려 더 나빠진 것 같아요. 밤이 오면 가슴이 쿵쥔거리고 숨이 안 쉬어져요. '또 시작이구나' 하는 생각이 들고 숨이 막힐 것 같을 때면 손을 꼭 쥐고 발바닥이 바닥에 닿는 걸 계속 느껴보려고 해요. 약을 바꿔도 나아질 수 있는지 궁금해함

## 정신상태검사 (MSE)

텍스트 기반 정신상태 메모 — 비구조화: 눈물이 이유 없이 나오고, 가슴이 덜컥 내려앉는 공황 증상, 무기력감, 업무 수행 불가  
개별 영역(mood/insight 등) 평가는 이 슬롯 특성상 불가

전체 세션 요약

이 표의 값은 AI가 진행한 대화형 문진(F1)에서 환자가 자가보고한 내용이며, 임상이의 직접 평가나 검증된 척도 시행이 아닙니다.

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 슬롯           | 최신값                                                                                            |
| 주호소          | 약을 두 번이나 바꿨는데도 증상이 오히려 더 나빠진 것 같고, 숨 쉬는 것조차 힘들며, 밤이 되면 가슴이 쿵쥔거리고 숨이 안 쉬어지는 공포가 지… (상세 부록 3 참조) |
| 현병력          | 약을 두 번이나 바꿨는데도 오히려 더 나빠진 것 같아요. 밤이 오면 가슴이 쿵쥔거리고 숨이 안 쉬어져요. '또 시작이구나' 하는 생각이 들고 숨… (상세 부록 4 참조) |
| 정신과 과거력      | 한 달 전 응급실 방문 시 공황 발작 경험                                                                        |
| 신체질환/신경학적 병력 | 미수집                                                                                            |
| 개인사/사회력      | 미수집                                                                                            |
| 가족력          | 미수집                                                                                            |
| 음주·흡연·물질사용   | 술은 가끔 와인 반 잔 정도 마심                                                                             |
| 위험평가         | 자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "아니요, 그런 건... 그냥 이 상태가 너무 무거워서. 숨 쉬는 것조차 힘들어요. 약을 바꿔도... (상세 부록 5 참조)  |

주요 경과

- 위험평가: S1: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "아니요, 저는 상담사가 아니라서 그렇게 말할 수 없어요. 제가...' → S5: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "아니요, 그런 건 없어요. 제가 생각해 둔 건 정말 없어요. 그...' → S10: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "아니요, 그런 건... 그냥 이 상태가 너무 무거워서. 숨 쉬는...'  
- 주호소: S1: '공황이 오는 게 너무 무서워요. 하루에 몇 번씩 '또 오면 어떡하지' 하는 생각이 떠나질 않아요. 어제는 아...' → S6: '아침마다 심장이 쿵쥔거리고 숨이 안 쉬어지는 공황 증상이 반복되며, 번역 업무 수행 불가로 경제적 어려움과...' → S10: '약을 두 번이나 바꿨는데도 증상이 오히려 더 나빠진 것 같고, 숨 쉬는 것조차 힘들며, 밤이 되면 가슴이 쿵...'  
- 현병력: S1: '하루 종일 이유 없이 눈물이 흐르고 손 떨림, 두통이 지속됨. 약을 먹어도 증상 호전 없음. 공황이 다시 올...' → S4: '아침마다 심장이 쿵쥔거리고 숨이 안 쉬어지는 공황 증상이 반복되며, 잠은 4시간 정도 자고 꿈은 더 자주 꿈...' → S10: '약을 두 번이나 바꿨는데도 오히려 더 나빠진 것 같아요. 밤이 오면 가슴이 쿵쥔거리고 숨이 안 쉬어져요. '...'

시행된 설문

AI가 진행한 대화형 문진 결과이며, 검증된 임상 설문 시행이 아닙니다.

PHQ-9 26/27 (중증) — 10회차 (2027-01-14)

응답: 3,3,3,3,3,3,3,2

자살사고 문항(9번): 양성 | 문진 방식: natural

종단 추세 — 전체 방향: 악화

전체 방향은 척도·위기단계·정서 방향의 다수결로 계산되며, 악화 신호가 하나라도 있으면 악화로 우선 판정합니다. 정서 포함 여부에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

| 항목          | 방향 | 근거                                       |
|-------------|----|------------------------------------------|
| PHQ-9 총점    | 악화 | PHQ-9: 세션 1→10: 26 → 26 (+0)             |
| 위기 단계(CTRS) | 개선 | 세션 1→10: 3 → 3 (+0)                      |
| 감성 점수       | 악화 | 세션 1→10: -0.795455 → -0.807273 (-0.0118) |
| 문진 항목 충족도   | 개선 | 세션 1→10: 3 → 5 (+2)                      |

- 위기 반응 발생 세션: 7회차(2026-09-16)
- 위험 고조 세션 중 설문 미시행 사례 없음
- 종단 추세 일관성(설문·CTRS·감성): 불일치

추세 차트

VP-004\_20260715\_164835\_temporal\_scales\_ctrs\_sentiment.png

# F4 종단 추이 — VP-004 VP-004

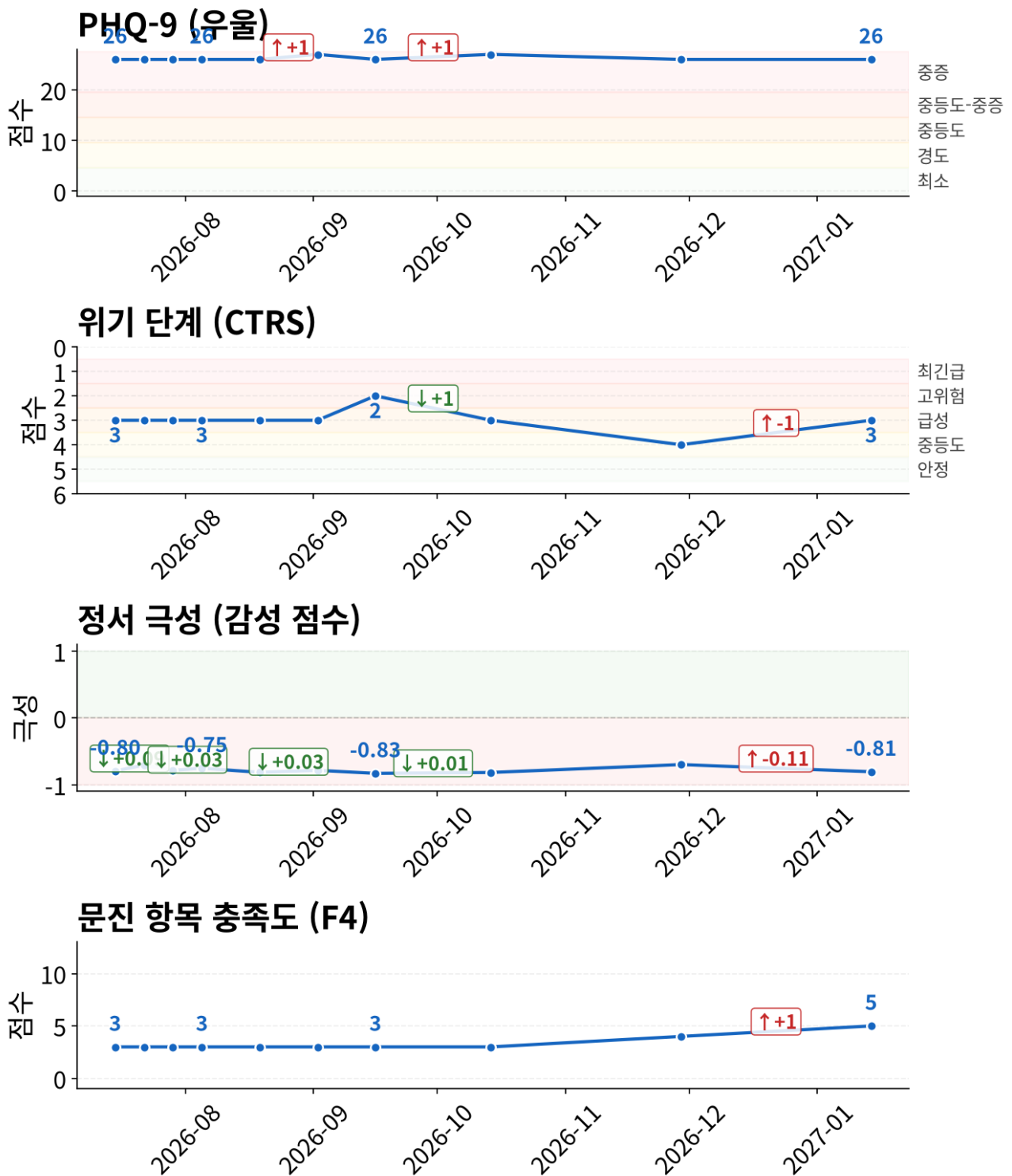


그림 1. 설문 총점·위기 단계(CTRS)·정서·문진 충족도 추이 (10세션, 183일) — 위기 단계는 값이 낮을수록(1에 가까울수록) 위험이 높습니다.

VP-004\_20260715\_164835\_temporal\_ctrs\_zoom.png

# F4 위기단계(CTRS) 확대 — VP-004

## VP-004

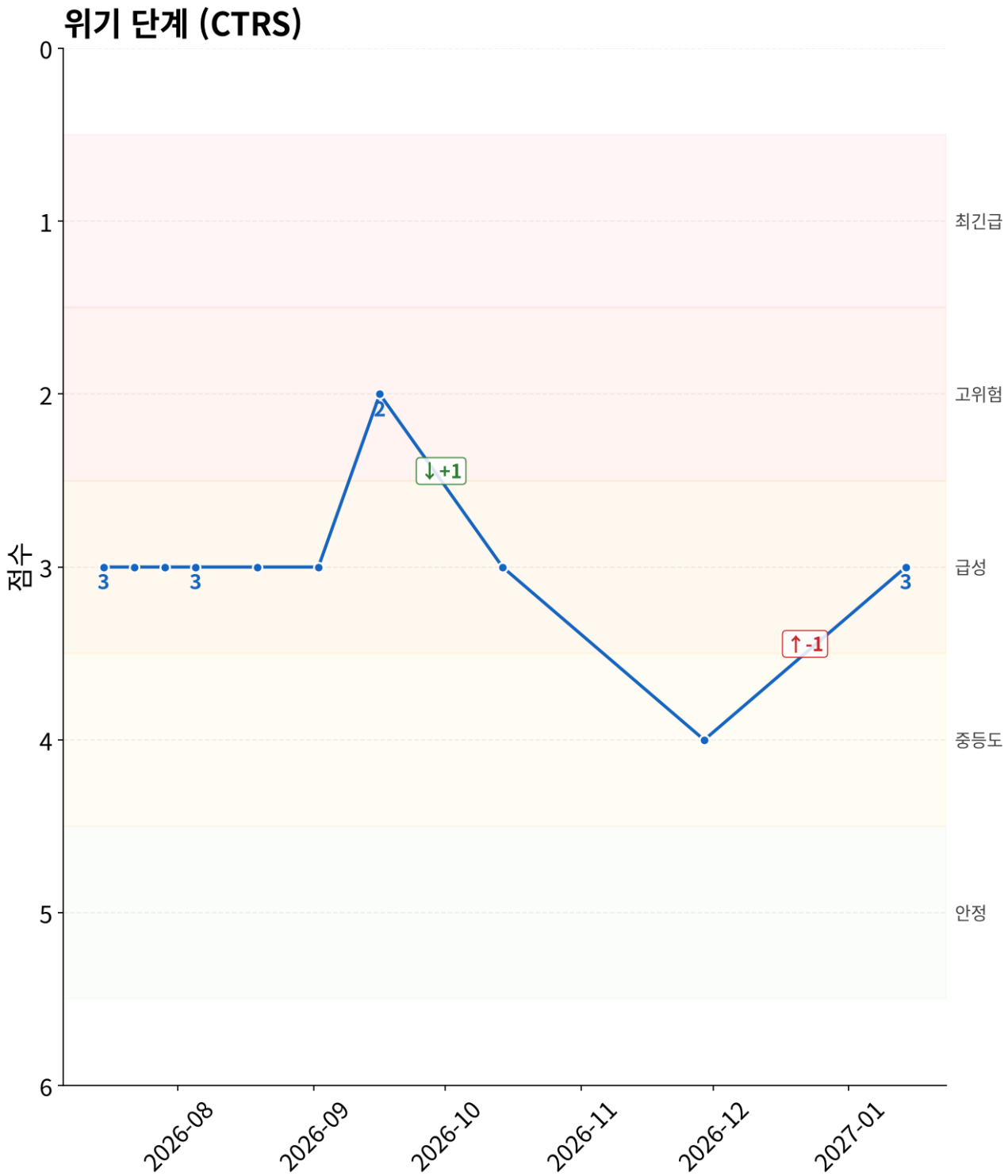
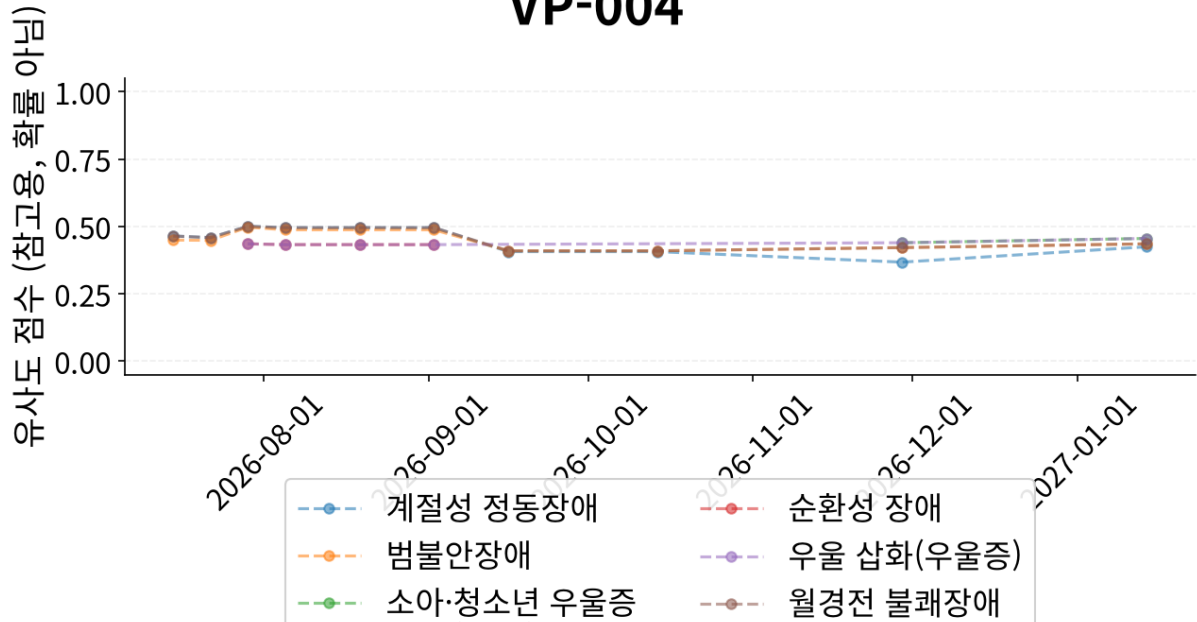


그림 2. 위기 단계(CTRS) 확대 추이 — 1(최긴급)에 가까울수록 위험, 5(안정)에 가까울수록 안정적입니다.

VP-004\_20260715\_164835\_temporal\_disease\_similarity.png

## 질환 유사도 추이 (F4, 질환별) VP-004

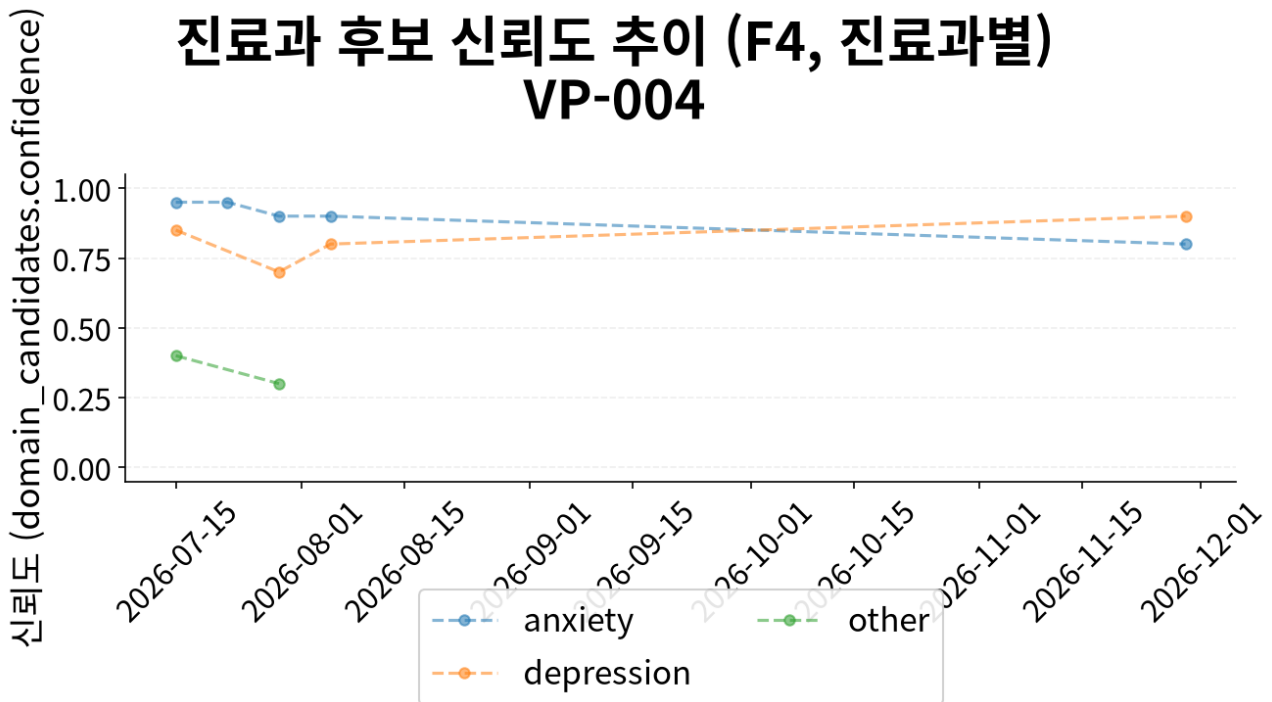


점선·저채도 선 = 낮은 신뢰도 시각 신호. VAL-014(마해결): F2 질환 후보 산출의 타당성이 아직 검증되지 않았습니다 — 이 추이는 노이즈가 포함된 입력을 기반으로 계산되며, 임상적 추이 해석 용도로 사용할 수 없습니다.

그림 3. 세션별 질환 유사도 추이 — 점선·저채도 선은 참고용 유사도 신호일 뿐이며 확률·가능성·진단이 아닙니다.

VP-004\_20260715\_164835\_temporal\_domain\_confidence.png

## 진료과 후보 신뢰도 추이 (F4, 진료과별) VP-004



점선·저채도 선 = 낮은 신뢰도 시각 신호.

그림 4. 세션별 진료과 후보 신뢰도 추이 — 값이 높을수록 해당 진료과 매칭 신뢰도가 높습니다.

AI 참고 정보 (비진단)

⚠ 유사도(similarity)일 뿐 확률·가능성·신뢰도가 아닙니다 — 임상 판단 대체 불가.

| 순위    | 질환         | 유사도   |
|-------|------------|-------|
| 공동 1위 | 우울 삽화(우울증) | 0.455 |
| 공동 1위 | 소아·청소년 우울증 | 0.455 |
| 공동 3위 | 범불안장애      | 0.435 |

기타 후보: 월경전 불쾌장애(0.435), 계절성 정동장애(0.424)

disclaimer: 이 정보는 AI가 생성한 참고용 예상 질환 후보이며 의학적 진단이 아닙니다. 함께 제공되는 설문 추천(recommended\_questionnaire) 역시 초기 상담(인테이크) 지원을 위한 척도 제안일 뿐, 진단적 판단이 아닙니다. 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

## 권장 진료과 및 후속 조치

이번 실행에서는 진료과 후보가 산출되지 않았습니다(후보 검증 단계에서 제외됨). 원 데이터는 각주 참조.  
추천 설문: PHQ-9 — PHQ-9 screens depressive-symptom burden only, does not screen manic/hypomanic symptoms — bipolar-spectrum presentations need clinician follow-up regardless of score.  
약물 정보: 별도 구조화 항목 없음, HPI/병력 서술 포함 여부만 확인

## 임상 종합 소견

AI 종합 소견 미생성 (narrative disabled)

## 상세 부록

### 1. 주호소 전문

약을 두 번이나 바꿨는데도 증상이 오히려 더 나빠진 것 같고, 숨 쉬는 것조차 힘들며, 밤이 되면 가슴이 쿵쾅거리고 숨이 안 쉬어지는 공포가 지속됨

### 2. 위험평가 발화 원문 (당해 세션)

자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "아니요, 그런 건... 그냥 이 상태가 너무 무거워서. 숨 쉬는 것조차 힘들어요. 약을 바꿔도... 이게 나아질 수 있는 건가요? 번역도 못하고..."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "잠깐... 잠깐만 어두운 방에 앉아 있으면 더 심해지는 것 같아요. 그래서 요즘은 아예 불을 끄고 눈을 감고 있어요. 숨이 막힐 것 같을 때면 ..."

### 3. 주호소 최신값 전문

약을 두 번이나 바꿨는데도 증상이 오히려 더 나빠진 것 같고, 숨 쉬는 것조차 힘들며, 밤이 되면 가슴이 쿵쾅거리고 숨이 안 쉬어지는 공포가 지속됨

### 4. 현병력 최신값 전문

약을 두 번이나 바꿨는데도 오히려 더 나빠진 것 같아요. 밤이 오면 가슴이 쿵쾅거리고 숨이 안 쉬어져요. '또 시작이구나' 하는 생각이 들고 숨이 막힐 것 같을 때면 손을 꼭 쥐고 발바닥이 바닥에 닿는 걸 계속 느껴보려고 해요. 약을 바꿔도 나아질 수 있는지 궁금해함

### 5. 위험평가 최신값 전문

자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "아니요, 그런 건... 그냥 이 상태가 너무 무거워서. 숨 쉬는 것조차 힘들어요. 약을 바꿔도... 이게 나아질 수 있는 건가요? 번역도 못하고..."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "잠깐... 잠깐만 어두운 방에 앉아 있으면 더 심해지는 것 같아요. 그래서 요즘은 아예 불을 끄고 눈을 감고 있어요. 숨이 막힐 것 같을 때면 ..."

## 슬롯별 전체 변화 이력 (미압축)

#### 주호소

S1: '공황이 오는 게 너무 무서워요. 하루에 몇 번씩 '또 오면 어떡하지' 하는 생각이 떠나질 않아요. 어제는 아침에 눈 뜨자마자 심장이 쿵쾅거리고 숨이 턱 막혔어요. 전화도 못 받고 바닥에 주저앉았어요.' → S2: '하루에도 여러 번 공황이 올까 봐 무서워하며, 아침에 눈 뜨자마자 심장이 뛰고 숨이 안 쉬어지는 증상이 지속됨. 전화도 못 받고 바닥에 주저앉는 등 일상생활에 지장을 받고 있음' → S3: '아침마다 심장이 쿵쾅거리고 숨이 안 쉬어지는 공황 증상이 반복되어 무서워하며, 번역 업무 수행 불가로 경제적 어려움과 죄책감을 호소하고 있음' → S6: '아침마다 심장이 쿵쾅거리고 숨이 안 쉬어지는 공황 증상이 반복되며, 번역 업무 수행 불가로 경제적 어려움과 죄책감을 호소하고 있음' → S7: '매일 죽을 것 같다는 생각이 들고, 공황 발작 시 심장이 터질 것 같고 숨이 안 쉬어져 벽에 기대 헉헉거리며, 번역 업무 수행 불가로 마감을 놓치고 수입이 없어 경제적 어려움과 죄책감을 호소하고 있음' → S9: '약을 두 번이나 바꿨는데도 증상이 오히려 더 나빠진 것 같음' → S10: '약을 두 번이나 바꿨는데도 증상이 오히려 더 나빠진 것 같고, 숨 쉬는 것조차 힘들며, 밤이 되면 가슴이 쿵쾅거리고 숨이 안 쉬어지는 공포가 지속됨'

#### 현병력

S1: '하루 종일 이유 없이 눈물이 흐르고 손 떨림, 두통이 지속됨. 약을 먹어도 증상 호전 없음. 공황이 다시 올까 봐 불안하고 두려운 생각이 하루에도 여러 번 들. 어제는 아침에 눈 뜨자마자 심장이 쿵쾅거리고 숨이 턱 막혔으며, 전화도 못 받고 바닥에 주저앉음. 어머니 전화도 받지 못함. 번역 업무 수행 불가로 클라이언트에게 세 번 사과함. 수입 없음으로 경제적 어려움 호소. '이대로 괜찮은 걸까요?'라는 자기 의문 표현' → S2: '하루 종일 이유 없이 눈물이 흐르고 손 떨림, 두통이 지속됨. 약을 세 번 바꿨으나 증상 호전 없음. 공황이 다시 올까 봐 불안하고 두려운 생각이 하루에도 여러 번 들. 어제는 아침에 눈 뜨자마자 심장이 쿵쾅거리고 숨이 턱 막혔으며, 전화도 못 받고 바닥에 주저앉음. 어머니 전화도 못 받아 죄책감 느낌. 번역 업무 수행 불가로 클라이언트에게 세 번 사과하고 수입 없음으로 경제적 어려움 호소. '이대로 괜찮은 걸까요?'라는 자기 의문 표현' → S3: '아침마다 심장이 쿵쾅거리고 숨이 안 쉬어지는 증상이 지속되며, 잠은 4시간 정도 자고 꿈은 더 자주 꿈. 에스시탈로프람 20mg 복용 중이나 별다른 변화 없고, 불안할 때 알프라졸람 0.25mg을 가끔 복용하나 도움이 안 됨. 두통과 손 떨림이 심해졌으며, 어머니 전화를 못 받아 죄책감과 외로움을 느끼고 있음. 번역 업무 수행 불가로 클라이언트에게 사과하고 수입 없음으로 경제적 어려움을 호소하고 있음' → S4: '아침마다 심장이 쿵쾅거리고 숨이 안 쉬어지는 공황 증상이 반복되며, 잠은 4시간 정도 자고 꿈은 더 자주 꿈. 에스시탈로프람 20mg 복용 중이나 별다른 변화 없고, 불안할 때 알프라졸람 0.25mg을 가끔 복용하나 도움이 안 됨. 두통과 손 떨림이 심해졌으며, 어머니 전화를 못 받아 죄책감과 외로움을 느끼고 있음. 번역 업무 수행 불가로 클라이언트에게 사과하고 수입 없음으로 경제적 어려움을 호소하고 있음' → S7: '2개월 전부터 시작된 공황 증상으로 잠 못 자고 눈물 하루 종일 나며 밥도 거의 못 먹음. 번역 업무 수행 불가로 마감 3건 놓치고 클라이언트에게 사과하며 수입 없음으로 경제적 어려움 호소. 두통, 근육통, 손 떨림 심해졌으며 에스시탈로프람 20mg 복용 중이나 별다른 변화 없고 불안할 때 알프라졸람 0.25mg 가끔 복용하나 도움 안 됨. 수동적 자살

사고('이러다 죽을 것 같다') 매일 수준으로 심해졌으나 구체적 계획 없음. 응급실 방문 경험 있음' → S9: '약을 두 번이나 바꿨는데도 오히려 더 나빠진 것 같아요' → S10: '약을 두 번이나 바꿨는데도 오히려 더 나빠진 것 같아요. 밤이 오면 가슴이 쿵쿵거리고 숨이 안 쉬어져요. '또 시작이구나' 하는 생각이 들고 숨이 막힐 것 같을 때면 손을 꼭 쥐고 발바닥이 바닥에 닿는 걸 계속 느껴보려고 해요. 약을 바꿔도 나아질 수 있는지 궁금해함'

#### 위험평가

S1: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "아니요, 저는 상담사가 아니라서 그렇게 말할 수 없어요. 제가 느끼는 건... 계속 눈물이 나요. 이유도 없이, 그냥 흐르거든요. 손도 떨리고 ..."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "아니요, 저는 상담사가 아니라서 그렇게 말할 수 없어요. 제가 느끼는 건... 계속 눈물이 나요. 이유도 없이, 그냥 흐르거든요. 손도 떨리고 ..."' → S2: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "...아니요, 구체적으로 계획한 적은 없어요. 근데 가끔 아프면 이 느낌이 좀 멈출까 싶을 때가 있어요. 근데... 한 적은 없어요."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "네, 약은 세 번이나 바꿨는데... 여전히 잘 안 낫더라고요. 가끔 아프면 이 감정이 좀 멈출까 싶어요. 근데... 한 적은 없어요." → S3: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "...아니요, 그 전화는... 필요 없어요. 근데 어머니 전화도 안 받아요. 울고 있는 목소리 들릴까 봐. 그래서 더 혼자인 것 같아요. 그리고..."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "아니에요... 정신과 다닌 지는 얼마 안 됐어요. 근데 약을 두 번이나 바꿨는데도, 오히려 더 나빠졌어요. 처음엔 구역질이 너무 심해서 멈췄고,..."' → S4: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "아니에요... 그냥 또 공황이 올까 봐 무서워요. 지난주엔 침대에서 못 일어나는데, 온몸이 떨리고 손이 덜덜 떨려서 글도 못 썼어요. 어제는 번..."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "아니에요... 그냥 또 오면 어떡하지 하는 생각만 들어요. 어제도 파일 열자마자 심장이 쿵쿵거리고 숨이 턱 막히더니, 방 안에서 꿈쩍도 못 했어..."' → S5: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "아니요, 그런 건 없어요. 제가 생각해 둔 건 정말 없어요. 그냥... 너무 아파서 이 감정이 멈췄으면 싶을 때가 있을 뿐이에요. 근데 한 적은 없..."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "숨이 안 쉬어질 때마다... 가만히 있진 못해요. 이불을 꼭 움켜쥐고, 숨을 참아요. 한 번은 응급실 갈 뻔했어요. 다시는 그런 거 안 오게 해야 ..."' → S6: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "...잠깐만요. 그 생각이 자꾸 떠올라서... 정말 무서워요. 근데... 한 적은 없어요. 근데 어제는 진짜로... 그냥 아무 데나 가서 눕고 ..."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "...그 생각이 자꾸 떠올라서... 정말 무서워요. 근데... 한 적은 없어요. 근데 어제는 진짜로... 그냥 아무 데나 가서 눕고 싶었어요. ..."' → S7: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "어머니한테 전화도 못 받아요. 울고 있으면 더 걱정하실 것 같아서... 눈 뜨고만 있으면 눈물이 나요. 잠은 3~4시간 밖에 못 자요. 예전엔 ..."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "처음이에요. 정신과 진료는 이번이 처음이에요. 2개월 전부터 시작했는데, 그때부터 계속 나빠졌어요. 잠도 못 자고, 눈물은 하루 종일 나고, 밥..."' → S8: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "아니에요, 그런 생각... 거의 매일 들어요. "이러다 진짜 죽는 거 아닐까" 하는 생각이 자꾸 들어요. 근데 죽고 싶은 건 아니에요. 그냥....."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "아니에요, 그런 생각... 거의 매일 들어요. "이러다 진짜 죽는 거 아닐까" 하는 생각이 자꾸 들어요. 근데 죽고 싶은 건 아니에요. 그냥....."' → S10: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "아니요, 그런 건... 그냥 이 상태가 너무 무거워서. 숨 쉬는 것조차 힘들어요. 약을 바꿔도... 이게 나아질 수 있는 건가요? 번역도 못하고..."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "잠깐... 잠깐만 어두운 방에 앉아 있으면 더 심해지는 것 같아요. 그래서 요즘은 아예 불을 끄고 눈을 감고 있어요. 숨이 막힐 것 같을 때면 ..."'

모델: solar-pro3-260323 · 생성 시각: 2026-07-15T17:31:02.115508 · 세션ID: f1\_VP-004\_followup

설문 문항 출처: v1, verbatim Pfizer/phqscreeners.com Korean PHQ-9 PDF, retrieved 2026-07-13 (item\_bank\_v1\_sources.md § 1.2/ § 1.3, appendix § A1); translation chosen per ADR-033 decision 1 (Seo & Park 2015's Korean validation study administered this same translation)

시스템 참고 (내부 감사용, 임상 판단 근거 아님)

종단 추세 판정 근거: overall\_direction은 세션별 척도/CTRS/sentiment 방향의 다수결(worsened-priority)로

계산되며(src.f4::\_overall\_direction), sentiment 포함 여부에 따라 verdict가 달라질 수 있습니다(REV-045 row 2) — 세부 근거는 trend\_verdicts의 evidence를 참고하십시오.

권장 진료과 미산출 원문(감사용): 정보 없음 — 후보가 스키마 검증 오류로 제외됨 (validation\_errors 존재, VAL-016/BUG-031 계열). 모델이 후보를 찾지 못했다는 의미가 아니라, 상위 F2 단계에서 이미 생성된 후보가 스키마 검증 실패로 삭제되었을 가능성이 있습니다.